PEDIATRIC NURSING (THEORY) · ESSAY PREDICTIONS

Pediatric Nursing — Theory Essay Questions — Predictions

تمريض الأطفال (نظري) — توقعات الأسئلة المقالي

22	8	9	5
Predicted essays	Very high	High	Medium

طريقة التوقع: (1) الأسئلة المقالي اللي الدفعة اللي قبلكم جمعتها في ملف «some essay Q in pediatric theory» من الجروب، (2) عدد مرات تكرار نفس الموضوع في أسئلة الميدترم والكويزات (البنك فيه 554 سؤال)، (3) وزن الموضوع في الملخص. «توقع عالي جداً» = موجود في ملف المقالي + متكرر جداً في الـ MCQ. «توقع عالي» = موجود في ملف المقالي. «توقع متوسط» = مش موجود في ملف المقالي لكنه متكرر في الـ MCQ ومهم في الملخص. مفيش توقع مضمون 100% — ذاكر الإجابات النموذجية دي كنقاط أساسية وكلّها من الملخص. المحاضرات اللي بره منهج الميدترم (Jaundice، Sepsis، DM، Leukemia...) اتشالت من الملف ده.

اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلَّا ما جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وأنتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سَهْلًا — صلِّ على النبي ﷺ

Predicted Essay Questions

الأسئلة المتوقعة مرتبة حسب قوة التوقع

E1 توقع عالي جدا

Enumerate the pre- and post-operative nursing care of children with cleft lip and/or cleft palate.

المحاضرة: العيوب الخلقية في الجهاز الهضمي (GIT Congenital Anomalies) — موجود في ملف المقالي، وأكتر من 10 أسئلة MCQ عن وضع الطفل والرعاية بعد العملية.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E2 توقع عالي جدا

List the pre- and post-operative nursing care of infants with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula (TEF).

المحاضرة: العيوب الخلقية في الجهاز الهضمي (GIT Congenital Anomalies) — موجود في ملف المقالي، و«prevent aspiration» من أكتر الإجابات تكراراً في الميدترمات.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E3 توقع عالي جدا

Write the pre- and post-operative nursing interventions for an infant with hypertrophic pyloric stenosis.

المحاضرة: العيوب الخلقية في الجهاز الهضمي (GIT Congenital Anomalies) — موجود في ملف المقالي، و«evaluate hydration status» جه في ميدترم 2020 وفي أكتر من كويز.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E4 **Enumerate the physiological handicaps of premature infants.** توقع عالي جدا

المحاضرة: حديث الولادة عالي الخطورة (High-Risk Neonate) — موجود في ملف المقالي، و«characteristics of prematurity» متكرر في الميدترمات.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E5 **Enumerate the advantages of breastfeeding for both the baby and the mother.** توقع عالي جدا

المحاضرة: الرضاعة الطبيعية (Breast Feeding) — موجود في ملف المقالي، والرضاعة عليها أسئلة MCQ في ميدترم 2022 و2024.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E6 **What are the nursing interventions for a child with spina bifida (myelomeningocele) pre-operatively?** توقع عالي جدا

المحاضرة: العيوب الخلقية في الجهاز العصبي (CNS Congenital Anomalies) — موجود في ملف المقالي، و«moist sterile dressing» و«prone» متكررين في كل الميدترمات تقريباً.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E7 **List the signs and symptoms of hydrocephalus in infants.** توقع عالي جدا

المحاضرة: العيوب الخلقية في الجهاز العصبي (CNS Congenital Anomalies) — موجود في ملف المقالي، وقياس محيط الرأس متكرر في كذا امتحان.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E8 **Write the nursing interventions for a neonate with respiratory distress syndrome (RDS).** توقع عالي جدا

المحاضرة: متلازمة الضائقة التنفسية عند حديثي الولادة (Respiratory Distress Syndrome (RDS)) — أول سؤال في ملف المقالي من الجروب + RDS عليها أكتر من 50 سؤال MCQ.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E9 **Enumerate the causes of prematurity.** توقع عالي

المحاضرة: حديث الولادة عالي الخطورة (High-Risk Neonate) — موجود في ملف المقالي.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E10 **List the nursing interventions for high-risk neonates.** توقع عالي

المحاضرة: حديث الولادة عالي الخطورة (High-Risk Neonate) — موجود في ملف المقالي، و«minimal handling» و«hand washing» متكررين في الكويزات.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E11 **List the different types of play according to developmental level.** توقع عالي

المحاضرة: اللعب (Play) — موجود في ملف المقالي، وأنواع اللعب أكتر حاجة متكررة في محاضرة Play.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E12 **What are the functions (values) of play in the hospital?** توقع عالي

المحاضرة: اللعب (Play) — موجود في ملف المقالي، و«release of tension / diversion» متكرر في الكويزات.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E13 **List the ten steps to successful breastfeeding (WHO/UNICEF).** توقع عالي

المحاضرة: الرضاعة الطبيعية (Breast Feeding) — موجود في ملف المقالي.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E14 **List the key messages for appropriate complementary feeding, and the foods to be avoided.** توقع عالي

المحاضرة: الرضاعة الطبيعية (Breast Feeding) — موجود في ملف المقالي (سؤالين).

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E15 **List the clinical manifestations of acute glomerulonephritis (AGN).** توقع عالي

المحاضرة: المتلازمة الكلوية والتهاب الكلى الحاد (Nephrotic Syndrome & AGN) — موجود في ملف المقالي، و«tea-colored urine» جه في ميدترم 2022 و2024.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E16 **What are the main goals of nursing management of nephrotic syndrome?** توقع عالي

المحاضرة: المتلازمة الكلوية والتهاب الكلى الحاد (Nephrotic Syndrome & AGN) — موجود في ملف المقالي، و«body image» و«daily weight» في الميدترمات.

المصدر: ملف المقالي من الجروب

E17 **Enumerate the risk factors, grades and prevention of RDS.** توقع عالي

المحاضرة: متلازمة الضائقة التنفسية عند حديثي الولادة (Respiratory Distress Syndrome (RDS)) — متكرر في الـ MCQ.

المصدر: توقع من الـ MCQ

E18 **List the factors affecting infant mortality rate and its leading causes in developed vs developing countries.** توقع متوسط

المحاضرة: منظور تمريض الأطفال (Perspectives of Pediatric Nursing) — مش في ملف المقالي، لكن متكرر في كل الكويزات الأولى.

المصدر: توقع من تكرار الـ MCQ

E19 **Define the basic ethical principles in pediatric nursing with an example for each.** توقع متوسط

المحاضرة: المبادئ الأخلاقية والقضايا القانونية (Ethical Principles & Legal Issues) — مش في ملف المقالي، لكن المحاضرة عليها حوالي 57 سؤال MCQ.

المصدر: توقع من تكرار الـ MCQ

E20 **Describe the stages of separation anxiety and the nursing interventions to minimize it.** توقع متوسط

المحاضرة: دخول الأطفال المستشفى (Hospitalization of Children) — مش في ملف المقالي، لكن protest/despair/detachment جت في أكتر من 8 أسئلة MCQ.

المصدر: توقع من تكرار الـ MCQ

E21 **Explain the active and passive preventive strategies of childhood accidents with examples according to age.** توقع متوسط

المحاضرة: الوقاية من الحوادث (Accident Prevention) — مش في ملف المقالي، لكن active/passive strategy جت في ميدترم 2024.

المصدر: توقع من تكرار الـ MCQ

E22 **Mention the modified Jones criteria and the nursing management of rheumatic fever.** توقع متوسط

المحاضرة: الحمى الروماتيزمية (Rheumatic Fever) — مش في ملف المقالي، لكن محاضرة RF عليها 46 سؤال.

المصدر: توقع من تكرار الـ MCQ

Model Answers

نقاط الإجابة النموذجية

E1. Enumerate the pre- and post-operative nursing care of children with cleft lip and/or cleft palate.

- Pre-op: routine preoperative care
- Feed upright to prevent aspiration
- Soft/special nipple, feed slowly
- Burp frequently (swallows air)
- Prevent lip infection; restrain arms if needed
- Teach parents feeding & dental hygiene; emotional support
- Post-op: maintain airway patency
- Protect suture line — elbow restraints, Logan bow
- Position: supine/side for cleft LIP; prone/side for cleft PALATE
- Gentle suction only if needed
- Clean suture line regularly
- Prevent crying (pressure on sutures)
- Clear fluids after anesthesia, then feed as before + mouth care
- Teach family care & follow-up

E2. List the pre- and post-operative nursing care of infants with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula (TEF).

- Pre-op: keep warm in incubator
- Withhold oral feeding (NPO)
- Continuous suction of upper pouch to prevent aspiration
- Position prone/supine with head elevated 30–40°
- Humidified oxygen
- Gastrostomy tube for decompression
- IV fluids; prepare for surgery
- Post-op: care of chest tube and gastrostomy tube
- Skin care around esophagostomy
- Oral stimulation with pacifier
- Routine post-op care; monitor intake & output
- Family teaching & follow-up

E3. Write the pre- and post-operative nursing interventions for an infant with hypertrophic pyloric stenosis.

- Pre-op: restore hydration & electrolytes with IV fluids (priority)
- Assess vomiting (amount, frequency, character)
- Monitor intake & output; record vomiting and stools
- NG tube for decompression
- General hygiene; family support; monitor growth
- Post-op: adequate hydration
- Surgical site care
- Maintain NG tube, oral hygiene
- Clear fluids 4–6 h after surgery
- Feed slowly, burp frequently
- Position high Fowler's on the right side after feeding
- Family teaching & follow-up

E4. Enumerate the physiological handicaps of premature infants.

- Temperature regulation: immature heat-regulating center, large surface area, little fat
- Respiratory: immature lungs/surfactant, weak chest muscles, apnea
- Infection: low maternal antibodies, weak immunity
- Liver: bleeding tendency (vit K), jaundice, low proteins → edema
- Kidney: poor urine concentration, fluid & salt imbalance
- Nutrition: weak suck, small stomach, deficiency of vitamins A, D, K

E5. Enumerate the advantages of breastfeeding for both the baby and the mother.

- Baby: complete nutrition for the first 6 months
- Passive immunity (colostrum, IgA)
- Fewer infections (diarrhea, otitis, respiratory), less asthma & diabetes
- Higher intelligence scores; less obesity
- Mother: lactational amenorrhea (child spacing)
- Faster uterine involution, less postpartum bleeding
- Lower breast & ovarian cancer risk
- Prevents iron-deficiency anemia; less insulin need in diabetics
- Bonding; less anxiety; economical

E6. What are the nursing interventions for a child with spina bifida (myelomeningocele) pre-operatively?

- Prevent sac injury/infection: sterile, moist (saline), non-adherent dressing
- Position prone (or lateral) — never supine
- Protect sac from urine/feces contamination
- Prevent increased ICP; measure head circumference daily
- Neurological assessment (LOC, leg movement)
- Prevent skin breakdown
- Support the family

E7. List the signs and symptoms of hydrocephalus in infants.

- Rapidly increasing head circumference
- Irritability, lethargy, poor feeding, vomiting
- Bulging (tense) anterior fontanel
- Widened/separated cranial sutures
- Cracked-pot sign (Macewen)
- Dilated scalp veins
- Sunset eyes
- High-pitched cry
- Late: bradycardia, apnea, seizures

E8. Write the nursing interventions for a neonate with respiratory distress syndrome (RDS).

- Non-respiratory: neutral thermal environment
- Avoid enteral feeding if O2 requirement >35%; IV fluids
- Prevent hypoglycemia
- Minimal handling; cardiorespiratory & SpO2 monitors
- Antibiotics (penicillin + gentamicin) after investigations
- Respiratory: clear airway, position (semi-Fowler's/prone) with monitoring
- Avoid frequent suctioning (apnea, hypoxia)
- Correct O2 — keep PaO2 50–80 mmHg
- Monitor ABG/capillary gases; intubate if PaCO2 >70
- Nasal CPAP; surfactant replacement via ET tube

E9. Enumerate the causes of prematurity.

- Fetal/pregnancy: IUGR, congenital anomalies
- Intrauterine infection & PROM
- Placental malformation/abnormal implantation
- Multiple pregnancy; chromosomal abnormalities
- Maternal: low socioeconomic status, extremes of age, malnutrition, anemia
- Smoking, drug addiction
- Chronic maternal disease (heart, renal, DM, HTN) and infections (TB)
- Antepartum hemorrhage; poor prenatal care

E10. List the nursing interventions for high-risk neonates.

- Respiratory support (airway, suction, oxygen)
- Thermoregulation (incubator/radiant warmer; prevent 4 ways of heat loss)
- Hydration monitoring (I&O, weight)
- Proper nutrition (gavage/breast milk)
- Infection prevention — meticulous hand washing
- Skin care
- Developmental care & minimal handling
- Family education and involvement

E11. List the different types of play according to developmental level.

- Newborn: sensory stimulation
- Infant: solitary play (sense-pleasure)
- Toddler: parallel play
- Preschool: sociodramatic/associative play
- School-age: constructive/cooperative play
- Adolescent: fantasy/day dreaming

E12. What are the functions (values) of play in the hospital?

- Provides diversion and relaxation
- Helps the child feel more secure
- Lessens stress of separation & homesickness
- Means of release of tension and expression of feelings
- Encourages interaction and positive attitudes
- Creative outlet
- Achieves therapeutic goals
- Places child in active role; gives chance for choices/control

E13. List the ten steps to successful breastfeeding (WHO/UNICEF).

- Written breastfeeding policy
- Train all health-care staff
- Inform pregnant women about benefits
- Initiate breastfeeding within 1 hour (30 :ملف المقالي دقيقة)
- Show mothers how to breastfeed & maintain lactation
- No food or drink other than breast milk unless indicated
- Rooming-in 24 hours
- Breastfeeding on demand
- No artificial teats or pacifiers
- Support groups after discharge

E14. List the key messages for appropriate complementary feeding, and the foods to be avoided.

- Breast milk alone is enough for the first 6 months
- A nutrient gap appears after 6 months
- Infant development prepares him for other foods
- Start complementary feeding at 6 months
- Complementary food must not replace breast milk
- Avoid: tea and coffee
- Avoid: carbonated beverages
- Avoid: sugary drinks and fruit juices
- Avoid: nuts (choking)

E15. List the clinical manifestations of acute glomerulonephritis (AGN).

- Hematuria (tea/cola-colored urine)
- Periorbital/facial edema (more in the morning)
- Oliguria, mild proteinuria, dysuria
- Hypertension
- Fever, anorexia, vomiting
- Abdominal discomfort
- Irritability, lethargy
- History of strep throat/skin infection 1–3 weeks before

E16. What are the main goals of nursing management of nephrotic syndrome?

- Reduce edema (daily weight, abdominal girth, I&O, sodium restriction)
- Encourage adequate nutrition
- Maintain intact skin
- Protect from infection (avoid sick contacts)
- Promote positive body image
- Educate family: steroids, urine protein testing, signs of relapse

E17. Enumerate the risk factors, grades and prevention of RDS.

- Risk: prematurity, male, maternal diabetes, cold stress, asphyxia, C-section
- Grade I: tachypnea, nasal flaring
- Grade II: intercostal/subcostal retractions
- Grade III: expiratory grunting
- Grade IV: cyanosis, altered consciousness
- Prevention: antenatal corticosteroids 24–34 wks, tocolytics, prevent cold stress

E18. List the factors affecting infant mortality rate and its leading causes in developed vs developing countries.

- IMR = infant deaths in first year /1000 live births
- Factors: birth weight (most important), gender, gestation, maternal age, maternal education
- Developing: acute lower respiratory infections, diarrhea, malnutrition, CHD, accidents
- Developed: congenital anomalies, short gestation/RDS, SIDS, maternal complications, sepsis, accidents
- Accidents = last cause in both

E19. Define the basic ethical principles in pediatric nursing with an example for each.

- Autonomy: self-determination — informed consent
- Beneficence: doing good — managing child's pain
- Non-maleficence: do no harm — EMLA cream before injection
- Justice: fairness — care by need
- Secondary: veracity (truth), fidelity (keep promises), confidentiality

E20. Describe the stages of separation anxiety and the nursing interventions to minimize it.

- Protest: cries, screams, clings to parent, rejects strangers
- Despair: inactive, withdrawn, sad, depressed, regression
- Detachment: superficial adjustment, ignores parent
- Interventions: rooming-in of mother
- Keep home routines & favorite objects
- Consistent caregiver; honest explanations
- Encourage visits; play activities

E21. Explain the active and passive preventive strategies of childhood accidents with examples according to age.

- Active: needs repeated action — store medicines locked, supervise bathing
- Passive: automatic — child-resistant caps, window guards, smoke detectors
- Infant: suffocation, falls, aspiration — back to sleep, no small objects
- Toddler: poisoning, burns, drowning — curiosity, lock cabinets
- School-age/adolescent: road traffic, sports injuries

E22. Mention the modified Jones criteria and the nursing management of rheumatic fever.

- Major: carditis, polyarthritis, chorea, erythema marginatum, subcutaneous nodules
- Minor: fever, arthralgia, raised ESR/CRP, prolonged PR
- + evidence of preceding strep infection (ASO, throat culture)
- Bed rest during acute phase
- Penicillin; salicylates; steroids for severe carditis
- Safety for chorea (risk for injury)
- Secondary prophylaxis: benzathine penicillin monthly till ~21 years